

EXAMEN HASHTAG 1, Type A :

- 1) Une politique trouve par l'observation de la statistique ci-dessus que le recul de la mortalité liée au tabac chez les femmes sur les 30 dernières années est plus lent que celui des messieurs (pas bête l'aztèque). Vous aimeriez créer une nouvelle mesure au niveau national contre ce phénomène. Qu'est-ce que vous pourriez proposer ?
- a) Une intervention immédiate permettant l'augmentation drastique de la taxe sur le tabac (ça c'est pour flo)
 - b) Une campagne ciblant les femmes (genre fumer ramolli les nénés)
 - c) Attendre l'évolution (après tout on est trop sur cette planète)
 - d) Faire adopter des lois cantonales anti-tabac strictes (font chier ces fumeurs)
 - e) Augmenter les primes d'assurance des fumeurs.
- 2) Quel paramètre montre une synthèse hépatique perturbée :
- a) Les transaminases
 - b) Bili
 - c) TP/INR
 - d) Gamma-gt
 - e) Thrombopénie
- 3) L'infirmière vous annonce que le patient qui doit se faire opérer dans deux heures et qui est à jeun depuis minuit a bu une tasse de thé aux herbes (l'enculé) à l'instant.... Que devez vous faire ?
- a) Dire au patient de ne plus rien boire dès maintenant
 - b) Repousser l'OP de 2heures (vive les téléphones)
 - c) Repousser l'OP de 4heures
 - d) Repousser l'OP de 24 heures car faut pas se fouttre de la gueule du monde non plus avec double dose de clexane, dans ta gueule
 - e) Ne prendre aucune disposition (et pk pas prendre un café avec lui)
- 4) Un enfant passé sous une tondeuse à gazon (polytrauma...) reçoit les examens suivants : CT cérébral, CT abdo et Rx du thorax (vois pas le rapport avec la tondeuse...) avec un total de 30 mSV. A quelles conséquences faut-il s'attendre ?
- a) Il y a peu d'effet secondaire potentiel
 - b) Il n'y a absolument aucun effet secondaire
 - c) L'enfant ne pourra avoir plus qu'une Rx thorax ou CT chaque X années
 - d) Avec la haute dose de méga rayons X toxiques qu'il a reçu on doit compter avec des effets déterministes comme la perte de cheveux ou des lésions de la peau (hé oui c'est qu'un enfant après tout...)
 - e) Il devrait faire des contrôles radiologiques réguliers afin d'observer l'évolution des effets.

- 5) Un patient schizophrène déjà pris en charge dans le milieu psy depuis 20 ans prend divers médicaments depuis 6 ans : Haldol, Akineton, Temesta. Il était aussi toujours agité ou agressif (mais jamais les deux, va savoir comment) mais son état était classifié comme plutôt stable. A la suite de symptômes dépressifs développés récemment (C'est clair c'est triste de taper tout ce qui bouge..) il reçoit un peu de sertraline (Zoloft). Ses proches remarquent qu'il a développé des mouvements bizarres avec la langue et la bouche et vous demandent d'où ça pourrait venir ?



- a) Ça fait partie du cours naturel de la schizophrénie (c'est pour ça qu'ils ne sortent plus de chez eux)
- b) Se développe suite au long cours d'utilisation de neuroleptiques
- c) Une interaction entre le nouvel SSRI et son Akineton (Biperdin)
- d) Ce sont les effets secondaires « parkinsoniens » de la sertraline
- e) Interaction SSRI et temesta (Lorazepam)

- 6) Quelle est le diagnostic le plus probable chez une femme avec 3 abortus spontanés et actuellement présentant une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse profonde (ha la vie de merde..) ?



- a) Le syndrome des plaquettes Sticky (collantes pour les intimes)
- b) Un trouble du facteur de vWB
- c) Un syndrome anti-phospholipide (anti-cellulite)
- d) Syndrome des ovaires polykystiques (poilue avec pleins de boutons)
- e) Un chromosome X fragile

- 7) Quelle est la cause la plus courante de fausses couches précoces ?



- a) Mauvaise nidation (tel l'oiseau)
- b) Une aberration chromosomique de l'enfant (sélection naturelle)
- c) La consommation d'alcool
- d) La prise de médicaments
- e) Une insuffisance du corps jaune (un indice : on ne parle pas du corps de la maman)

- 8) Un gamin de 4 semaines vous est apporté à votre consultation (hé oui t'es déjà médecin), léthargique avec une température légèrement élevée. Vous trouvez une petite hépatosplénomégalie, des croûtes autour du nez causées par le rhume ainsi que des papules brunes sur le front. Quelle suite de PEC ?



- a) Mesure du taux d'IgM pour syphilis
- b) Mesure par PCR à la recherche de syphilis (ça fait deux fois syphilis, bizarres...)
- c) Recherche d'anticorps contre la Toxoplasmose (le mari ne voulait pas vider la caisse du chat...)
- d) Recherche de CMV dans urines
- e) Rechercher la listériose dans le sang

9) Un homme de 45 ans est installé, posé pépère, aux urgences avec une colique néphrétique droite. Les SV sont TA 120/70 (fuck les unités), P 90/min, T 38.5. pas d'ATCD. Le CT montre un cailloux gros de 5mm (c'est déjà de la bonne pierre) au niveau du milieu de la zone de constriction de l'uretère droit (au moins on voit tous où c'est st'histoire) avec une dilatation proximal de l'uretère ainsi que des calices rénaux (pas sûr de ce mot en FR). Quelle suite de Pec (mnt qu'on t'a filé tout le diagnostic) ?

- a) Prescrire de l'analgésie et RAD (ATTENTION : rien à voir avec anus !!)
- b) Re-prescrire de l'analgésie mais hospitalisé pour observation (pas les couilles de le laisser rentrer...)
- c) Prescrire des ABTTT (c'est peut-être infecté st'histoire !)
- d) Une bonne vieille lithotripsie (extracorporelle) ça ne peut pas faire de mal
- e) Direct au bloc pour débloquer et prescription d'ABTTT

10) Un homme de 75 ans connu pour une sévère KHK (je vous laisse deviner c'est plus marrant) et une pneumopathie obstructive moyennement sévère, qui récemment s'est redécompensée suite à une nouvelle infection aussi lors de cette hospitalisation (les allemands avec leurs phrase tordues...). Le AA (médecins assistants suisse allemand. UU = unterhund=stagiaire) en charge du patient lui demande ses volontés (l'attitude) en cas de réanimation (désolé j trouve plus les mots... ha oui les directives anticipées, merci Barras) car :

- a) En CH c'est obligatoire
- b) Dans chaque situation, ses vœux seront réalisés (heu...comme dans Aladin ?)
- c) Ca lui permet d'exprimer ses souhaits au cas où il ne serait plus en mesure de le faire par la suite à cause d'un problème d'ordre médical (#ilsnontpastrouvélasouchedelinfection...)
- d) Grâce auxquels aucune discussion ne survient plus tard
- e) Grâce auxquels personne ne devra être désigné comme représentant thérapeutique plus tard

11. Homme de 80 ans, athérosclérose, détresse respiratoire aigue, visage bleu et mousse sortant de la bouche, et ne peut plus, pour cette raison, s'exprimer verbalement. TA : 240/130. Diagnostic ?

- Dissection aortique
- crise hypertensive
- embolie pulmonaire ou OAP ? (je suis pas sure, zentrale LE)
- myocardite fulminante
- tamponnade

12. Un jeune homme se présente aux urgences avec des douleurs testiculaires apparues subitement. Le médecin remarque un scrotum oedémateux et la couille se trouve un peu plus haut que l'autre. Pas de symptôme urinaire. Quel est la prochaine chose à faire ?

- refroidire

- antibiotique
- la mettre en position haute (hochlagern) -> diminuer l'œdème ? haha
- ponction
- exploration chirurgicale

13. Une radio babygramm d'un bébé ou on voit de l'air dans les anses intestinales, ainsi qu'une sonde nasogastrique qui vire/dévie/tourne au niveau du cou. Diagnostic ?

- iléus
- invagination
- fistule oesophagienne
- atresie oesophagienne
- perforation intestinale

14. un alcoolique est hospitalisé après un accident. Le 3^{ème} jour il est désorienté et a un nystagmus. Temperature et signes vitaux ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?

- Thiamine
- benzo
- pyridoxine (B6)
- neuroleptique (haldol)
- becozym forte (B12)

15. on fait une radio du thorax à une dame. On sait par la suite qu'elle est enceinte, 8 SA. Les suites pour l'enfant ?

- une interruption de la grossesse est indiquée
- principe de tout ou rien, soit il a rien soit il meurt
- amniocentese et biopsie des villosités chorales pour diagnostiquer une anomalie chromosomique
- il y aura une microcéphalie et un retard du développement
- ce n'est pas une dose tératogène

16. un banquier célibataire de 58 ans va chez le médecin à cause d'une fièvre à 38.9°C, toux, il est en mauvais état général. FR 38/min, FC 118/min, TA 95/65, crépitants entendu sur un hémithorax, auscultation cardiaque normale.

- fébrifuge et renvoyer à la maison
- Rx du thorax et si positif, antibiotique
- antibiotique et contrôle à 3 jours
- antibiotique et contrôle à 1 jour
- envoyer à l'hôpital

17. une fille de 5 ans est amenée à l'hôpital par ses parents en raison d'une forte dyspnée et de douleurs abdominales. Ils disent qu'elle était en vacances dans une ferme. La dyspnée a commencé soudainement le matin et elle a refusé tous les repas à cause de douleurs en avalant. À l'examen on entend un stridor inspiratoire important et un râle à l'expiration. Temp : 39.8. Diagnostic le plus vraisemblable ?

- Epiglottite
- pseudocroup
- pneumonie
- asthme
- bronchiolite

18. naissance sans complication, la mère rentre après 48h à la maison. Qu'est-ce qui doit absolument être contrôlé/fait ?

- vitamine A, D, C, K ou E ?

19. un nouveau-né développe un ictère néonatal. L'oncle est connu pour une déficience en G6PD. Qu'est-ce qui doit absolument être fait avant que la mère ne rentre à la maison avec son bébé 48h après la naissance ?

- guthrie
- test d'audition
- test de vision
- tester la bilirubine
- glycémie

20. une dame de 76 ans présente une baisse de l'audition progressive sur une année. Weber non latéralisé, Rinne positif bilatéralement. A l'audiométrie, les ondes diminuent à partir de 1000Hz bilatéralement. La dame voudrait savoir quelle thérapie ou pourrait lui proposer.

- implant cochléaire
- appareil auditif uni ou bilatéraux
- implant à ancrage osseux (transmission osseuse)
- stapedotomie bilatérale
- pas besoin de thérapie

21. Un homme âgé de 86 ans. Après une pneumonie, il s'est bien remis et il est prêt pour la sortie. Il souffre de vertige (déjà avant son entrée à l'hôpital). Avec l'aide du CMS, il vit seul chez lui dans un appartement adapté à sa chaise roulante et il peut se charger en partie seul de son approvisionnement (cuisine, courses).

L'assessment multimodulaire donne les résultats suivants:

- Mini-Mental-Test: 26/30 (norme >27)
- Capacités quotidiennes légèrement réduite
- Go test: ralenti, tendance à une chute en arrière (risque de chute arrière)

Quelle aide à la mobilité lui conseillez-vous?

- (a) Canne
- (b) Tintébin
- (c) Rollator (tintébin sur roulette)
- (d) Chaise roulante
- (e) Aucune aide au déplacement n'est nécessaire

22. Femme âgée de 36 ans avec une myopie qui a augmenté au cours de l'année écoulée passant de -3Dpt à -4Dpt. Elle souhaiterait désormais que vous lui donniez des informations sur la technique du Lasik. Quelles affirmations sont justes/valables pour elle?

- (a) Sa capacité visuelle serait plus augmentée par une lentille artificielle que par Lasik.
- (b) 70% des patients qui ont été traités au laser se sentent ensuite moins éblouis.
- (c) La capacité d'accommodation diminuerait suite au traitement laser.
- (d) La possibilité qu'elle aurait après l'opération une capacité visuelle de -0.5 à + 0.5Dpt s'élève à env. 80%.
- (e) L'opération au laser permet d'arrêter à coup sûr la progression de la myopie

23. Une jeune femme se présente à votre consultation avec les symptômes typiques d'un syndrome du canal carpien. Quels examens entreprenez-vous pour vous assurer du diagnostic? (Abklärung = clarification)

- (a) Radio dans le 2 plans
- (b) IRM
- (c) CT
- (d) Electroneurographie
- (e) Aucun examen n'est nécessaire, il faut directement passer à l'opération.

24. Une jeune infirmière voyage pendant 2 semaines au Vietnam et Indonésie. Déjà lors de son voyage, elle présente les symptômes suivants : Diarrhée, douleurs abdo et fièvre. Quel diagnostic peut-on exclure, le plus probablement ?

- a. HIV
- b. Hépatite B
- c. Malaria
- d. Salmonelle
- e. Cholera

25. Un homme connu pour une dysfonction thrombocytaire se coince la main dans une porte de camion. Le bras est actuellement très douloureux et la main oedématiée. De plus, le patient présente des paresthésies dans le doigt IV/V. Le pouls brachial (distal) n'est pas palpable. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Fracture du scaphoïde
- b Fracture du métacarpe
- c. Sy. Tunnel Carpien
- d. Compression du n. ulnaire causé par un gros hématome
- e. Syndrome des loges

26. Un homme de 35 ans rapporte une perte d'énergie, polyurie et perte pondérale de 7kg dans les 6mois (actuel : 55kg pour 170cm). L'homme est originaire du Sri Lanka et vit depuis 10ans en Suisse. Son dernier voyage au Sri lanka remonte à 5 ans. Depuis, l'homme n'est plus allé à l'étranger. Quel est la suite de la prise en charge ?

- a. RX thorax
- b. US abdominal
- c. Glycémie
- d. Test à la tuberculine
- e. Status urinaire et culture d'urine

27. Une femme portugaise, mère de 3 enfants, se présente pour des dorsalgies, fatigue et une perte pondérale de 8kg en 1 mois. Elle rapporte ne plus avoir ressenti d'émotion positive. De plus, elle se plaint de troubles du sommeil, diarrhée. En raisons de problèmes familiaux, elle a eu beaucoup d'absence au travail (caissière dans un grand magasin) ce qui l'a conduit à perdre son poste, majorant son sentiment de culpabilité.

Labo sanguin et IRM sont sans particularité. Les douleurs L5 bilatérales sans irradiation. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Canal lombaire étroit
- b. Episode dépressif avec somatisation
- c. Maladie de Crohn
- d. Syndrome d'épuisement chronique (fatigue chronique ? Chro. Erschöpfungssyndrom)

e. Trouble de l'adaptation

28. Quel est le paramètre le plus fiable pour évaluer l'effet d'une thérapie oncologique

- a. Réponse
- b. Bénéfice clinique
- c. Qualité de vie
- d. Liberté de progression
- e. La survie

29. Un garçon de 3 ans se présente chez son pédiatre pour une toux persistante accompagnée de fièvre entre 37.3 et 37.8. Dans ses antécédents, on retrouve 2 épisodes de bronchite asthmatiforme. Il y a 10 jours, en mangeant des cacahuètes (quel idiot), il a soudainement toussé sans cyanose.

A l'auscultation, une sibilance est audible sur la plage pulmonaire gauche. Quel suite de prise en charge est indiquée ?

- a. Pas d'exa complémentaire, donner antibiotique
- b. Pas d'exa complémentaire, antibiotique et bronchodilatateur
- c. CT thorax et si pas d'anomalies, pas d'exa complémentaire
- d. RX thorax et si pas d'anomalie, pas d'exa complémentaire
- e. RX thorax et même en l'absence d'anomalie, bronchoscopie

30. Où ne retrouve-t-on pas de lésions de charriage ?

- a. Genou
- b. Dos du pied
- c. Dos de la main
- d. Coude
- e. Front

31) Un homme de 50 ans vous consulte pour un « check up » avant de signer une assurance vie. Monsieur a un BMI de 29, l'auscultation cardio/pulmonaire ne présente rien d'anormal. Monsieur se sent en bonne santé et nie toute consommation d'alcool.

LABO : ASAT/ALAT élevé (env. 80 U/L), Y-GT normal, Bilirubine totale normale, Ferritine 400 ng/ml, capacité de saturation de la transferrine 40%

Quel diagnostic est le plus probable ?

- 1) Hépatite A
- 2) Hépatite alcoolique
- 3) NASH
- 4) Cirrhose hépatique
- 5) Hémochromatose

32) Une femme de 50 ans vous consulte en raison de trouble de la concentration progressif, de fatigue, d'une incertitude à la marche. Au frottis sanguin, on remarque des fragmentocytes ainsi que des Neutrophiles hyper segmentés.

LABO : Hb 8,1g/L

Thrombocytes 100G/L

Leuco 2,8 G/L

Creatinine 60 umol/L

Bilirubine 14 μ mol/L
LDH 1526 U/L

Quelle est la meilleure thérapie de ce diagnostic présumé ?

- 1) Fer
- 2) Phlébotomie
- 3) Méthylprednisone en haute dose
- 4) Vit B12
- 5) Plasmaphérèse

33) Une femme enceinte se réjouit des vacances d'hiver qui commencent le lendemain. Mais quelques heures après avoir mangé du fromage frais elle développe de la fièvre et des douleurs diffuses aux membres. Sa fille rentre de l'école et lui raconte comment un de ses potes a la varicelle depuis hier.

Quelle est l'étiologie la plus vraisemblablement responsable de la symptomatologie de la mère ?

- 1) infection virale
- 2) salmonelle
- 3) varicelle
- 4) Listeria
- 5) Mycoplasma

34) Un patient présente depuis plusieurs semaines une symptomatologie typique d'hyperthyroïdie avec une FA.

Quels médicaments peuvent être responsables de la symptomatologie ?

- 1) Amiodarone
- 2) Amlodipine
- 3) Atorvastatine
- 4) Metoprolol
- 5) Ramipril

35) Une étude randomisée doit démontrer l'influence du poisson sur les taux de cholestérol sanguin. Les sujets de l'étude ont reçu pendant 1 mois 3x/semaine un repas à base de poisson alors que le groupe contrôle ne mangeait pas de poisson. Après 4 semaines l'intervalle de confiance s'élève à 95% et pour le groupe contrôle on note un changement de concentration de -14mmol/L ; alors que pour le groupe qui a bénéficié du régime on note un changement de concentration de -27mmol/L. $p=0.05$

Quelle affirmation est la correcte ?

- 1) il existe une baisse du cholestérol significative dans le groupe ayant bénéficié de l'intervention
- 2) Les informations données ne suffisent pas pour dire si le résultat est significatif ou pas
- 3) La baisse de cholestérol n'est pas significative
- 4) L'intervalle de confiance est plus petit pour les cohortes plus petites
- 5) La baisse comparative de 13mmol/L dans le groupe à régime n'est pas significative

36) Une fille de 18 mois est amenée chez le pédiatre par sa maman avec l'impression que la jambe de sa gamine est toujours tordue. Elle a été allaitée entièrement pendant 12 mois et n'a

jamais eu de complément de Vit D. A l'examen clinique on remarque des proéminences osseuses en regard des côtes ainsi qu'un genou valgum.

Quel résultat de laboratoire irait avec le diagnostique présumé ?

- 1) une baisse marquée de la 1,25 Dihydroxy-Vit D
- 2) Une augmentation de la 1,25 Dihydroxy-Vit D
- 3) Une élévation du phosphate
- 4) Une élévation marquée de la phosphatase alcaline
- 5) Une PTH dans les normes

37) Un Homme de 66 ans présente des symptômes d'angine de poitrine à l'effort. L'examen clinique ainsi que l'ECG sont normaux.

Quel examen est à demander ?

- 1) échocardiographie trans-thoracale ?
- 2) un Holter ECG?
- 3) Une ergométrie ?
- 4) Angiographie des coronaires ?
- 5) Une scintigraphie de perfusion ?

38) Une jeune femme se plaint d'un gonflement bilatéral pré tibial de consistance ferme et « nodulés ». A part un inhibiteur de l'ovulation, elle ne prend pas de médicaments. Elle est connue pour une maladie coeliaque qui est bien contrôlée par un régime. Une anamnèse familiale pour un psoriasis est également relevée.

Quelle est la cause de cette présentation ?

- 1) coeliquie
- 2) Inhibiteur de l'ovulation
- 3) Psoriasis
- 4) Sklerodermie
- 5) Maladie de Wegener

39) Un homme de 40 ans se plaint de remontées acides jusque dans le cou depuis 2 mois. Les symptômes se produisent surtout après les repas et en position couchée. Le patient ne présente pas de diarrhées, de vomissements de douleurs abdominales ou de sang dans les selles. Le patient n'a pas perdu de poids et son appétit est conservé. L'anamnèse personnelle révèle une appendicectomie dans l'enfance. Des symptômes identiques sont apparus dans le passé mais étaient de courte durée. Le patient boit 2 verres de vin par jour, boit 3 cafés par jour et ne fume pas.

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de ce patient ?

- 1) lui donner des antiacides
- 2) diminuer sa consommation de cafés
- 3) lui donner de la ranitidine
- 4) lui donner de l'omeprazole
- 5) faire une oesogastroduodenoscopie

40) Une patiente de 91 ans habitant seule est amenée aux urgences après une chute. L'anamnèse révèle une légère sténose aortique. Avant la chute, la patiente n'a pas ressenti de vertige et elle s'est encoulée au tapis. La patiente nie toute perte de connaissance. Elle se plaint d'une légère douleur en regard du muscle moyen fessier mais peut rester debout et marcher. Il y a une mobilité libre du bassin et de la hanche et la colonne n'est ni sensible aux secousses ni à la percussion.

Quelles investigations entreprendriez-vous ?

- 1) Holter ECG ?
- 2) CT de la tête
- 3) Echocardiographie
- 4) Scintigraphie osseuse
- 5) Une évaluation multidisciplinaire gériatrique

41. Une fillette de 4 ans rapporte avoir des douleurs au genou D après une chute. La mère découvre un gonflement de ce genou. Depuis, la fillette a des douleurs, surtout la nuit, aux deux genoux ainsi qu'à la cheville droite. Elle est afebrile et en bon EG. CRP <3mg/dl, VS 25mm/h.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Borreliose de Lyme
- b) Arthrite juvénile idiopathique
- c) Hémarthrose
- d) Arthrite réactive
- e) Leucémie

42. Une femme de 52 ans, sans histoire familiale positive ni symptômes, veut une mammographie.

Pourquoi conseillez-vous la mammographie ?

- a) La mammographie a une spécificité de 90%
- b) Une sensibilité de 70%
- c) Il y a peu de résultats faussement positifs
- d) Il a des études qui prouvent la diminution de la mortalité chez les femmes à partir de 50 ans
- e) Le screening pour la mammographie devrait être commencé chez les femmes à partir de 40 ans

43. Une patiente de 56ans vous consulte car elle s'est mesuré une glycémie de 7.2 avec l'appareil de sa sœur diabétique. Elle a peur de souffrir elle-même de diabète également et aimerait plus d'investigations. Elle ne souffre pas de polyurie, ni d'une augmentation de la fatigue ou d'une perte de poids. Quel test d'investigation entreprenez-vous ?

- a) oGTT
- b) Mesurer le taux d'insuline dans le sang
- c) Mesurer la glycémie à jeun
- d) Mesurer le taux de glucose dans les urines
- e) Mesurer le taux de HbA1c

44. Un randonneur développe des lésions kératosiques sur les oreilles, le nez et les lèvres après un tour en montagne. Il a bénéficié d'une transplantation rénale il y a quelques années pour un rein polykistique. On lui a déjà recommandé d'appliquer régulièrement de la crème solaire.

Qu'est-ce que vous lui recommanderiez en plus ?

- a) Le patient devrait renoncer à des activités outdoor
- b) Le patient devrait éviter toute exposition au soleil
- c) Appliquer une crème grasse sur les lésions
- d) Le patient devrait à l'avenir se contrôler tout seul et revenir à l'apparition de nouvelles lésions.
- e) Des contrôles dermatologiques réguliers

45. Un enfant de 9 ans vous est présenté par sa mère car il se développerait plus lentement comparé à ses camarades. Les résultats de l'examen physique sont les suivants :

Taille : -2.8 SD

Pois : -3.2 SD

TSH : 0.8mU/L (normal bas)

T4 libre: 5 pmol/L (trop bas)

Quelle est votre suspicion diagnostique pour l'instant ?

- a) Insuffisance Adénohypophysaire
- b) Déficit en Hormone de croissance
- c) Hypothyroïdisme primaire
- d) Retard de croissance psychosocial
- e) Coeliaquie

46. Une femme de 47 ans est adressée aux urgences par son médecin traitant en raison d'un élargissement abdominal et d'une prise de poids. Elle était toxicodépendante, a été traitée sans succès pour une hépatite C et avait une sérologie positive pour l'hépatite B. Elle arrive saoule et en mauvais état général. Ses bras sont recouverts d'hématomes. Le foie n'est pas palpable en raison d'un ascite douloureux. La cheville (/malléole ? « knöchelgend ») est gonfle. Le labo montre :

Albumine 25g/l

INR 1.8

Bilirubine 52 micromoles/l

Thrombocytes 57G/l

Hb 11.8g/l

Quelle est la première chose à faire ?

- a) Corriger les thrombos et l'INR
- b) Ponction d'ascite
- c) Hémocultures
- d) MRI de tout l'abdomen
- e) Oesophago-gastro-duodénoscopie

47. Une jeune de 17ans connue pour une neurodermite vient vous voir. Les symptômes se seraient améliorés ces dernières années. Pourtant depuis deux mois, des rougeurs démangeantes apparaissent sur ses deux paupières (abb. an Prüf.). Elle les traite avec ses médicaments habituels pour la neurodermite après quoi elle remarque une amélioration rapide, sauf que les symptômes reprennent ensuite peu de temps après.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Dermatite de contact
- b) Dermatite seborrheique
- c) Dermatomyosite
- d) Lupus systémique érythémateux
- e) Progression de la neurodermite

48. Une petite fille de 3 mois, née prématurément, souffre de changements cutanés au niveau de la région des couches qui ne guérissent pas malgré l'apport des meilleurs soins.

Quelle déficience pourrait en être à l'origine ?

- a) Magnésium
- b) Calcium
- c) Fer
- d) Acide folique
- e) Zink

49. Une fillette de 4ans est apportée chez le médecin par sa mère en raison d'œdèmes. La mère raconte que la fille était peut-être un peu enrhumée mais que depuis tout était rentré dans l'ordre. Le médecin met en évidence une protéinurie de l'ampleur de celle d'un syndrome néphrotique. On ne décèle pas de sang dans l'urine que ce soit micro- ou macroscopiquement. La TA est normale, la VS augmentée.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Minimal change glomerulonephritis
- b) IgA Nephritis
- c) Glomérulonéphrite aigue post-infectieuse
- d) Nephrite interstitielle
- e) Nephrite lupique

50. Un garçon de 16 ans souffre depuis plusieurs semaines de douleurs au niveau du fémur distal droit, au-dessus du genou (métaphyse), à la charge. Il rapporte également un gonflement des tissus mous en regard de sa douleur. Quel diagnostic posez-vous sur la base de cette image microscopique ? (cf doc allemand)

- a) osteosarcome classique
- b) Chondrosarcome osteoblastique
- c) Osteosarcome chondroblastique
- d) ostéomyélite chronique

e) Osteochondrome à cellules géantes

51. Femme de 35ans, est amenée aux urgences pour une baisse de l'état général d'installation rapide. A l'examen clinique vous trouvez une tuméfaction importante, un érythème ainsi qu'une grande vésicule sur la jambe droite. A l'anamnèse la patiente se rappelle vaguement d'une blessure avec une ronce en coupant des roses. Quel prochain examen est indiqué ?

- a) Un frottis de la blessure
- b) IRM
- c) Révision chirurgicale
- d) ATB
- e) Prise de sang

52. Comment reconnaissez-vous si un homme s'est noyé en eau douce ou en eau salée ?

- a) Sang dilué
- b) Emphysema aquosum
- c) Oedème pulmonaire alvéolaire
- d) Mains de lavandière
- e) Chaire de poule

53. Patient à l'étage après un séjour aux SI, désorienté, Temp 38,6°C, veut enlever son cathéter. Extrémités chaudes et marbrées. Cette situation n'est pas nouvelle et dure depuis plusieurs jours. De quoi s'agit-il ?

- a) Choc anaphylactique
- b) Choc cardiogénique
- c) Choc hypovolémique
- d) Choc obstructif
- e) Choc septique

54. Un homme de 50 ans vous consulte parce qu'il présente depuis 8 semaines une dyspnée avec toux productive. Il y a 4 semaines son MT lui a prescrit 10j d'augmentin, et s'en était suivi une légère amélioration des symptômes. Malgré cela il présente toujours de la toux, une température subfébrile, une dyspnée ainsi qu'une perte pondérale de 11kg en 8 semaines. La Rx thx montre une ombre sur le poumon droit. Que prévoyez-vous de faire ensuite ?

- a) Recherche de TCB
- b) Test quantiféron et un IGRA (interferon gamma release assay)
- c) CT-thorax
- d) Test de Mantoux-Mendel
- e) Autre ATB

55. Femme de 45 ans, avec un Ca mammaire métastasé se présente aux urgences avec une symptomatologie d'iléus et des vomissements importants. 3e récurrence du cancer, actuellement sous chimiothp palliative. Depuis le début de la chimio, progression de la maladie et découverte d'une carcinose péritonéale. Les chirurgiens décident d'ouvrir l'abdomen. Quel est la *prochaine* mesure thérapeutique ?

- a) Chimiothp intrapéritonéale
- b) Hormonothp
- c) Rxthp
- d) Laparoscopie
- e) Sonde gastrique et inhibiteurs des sécrétions

56. Jeune fille de 10 ans a fait une chute à vélo il y a 1h et s'est cogné la tête. Ses parents l'amènent aux urgences. A l'anamnèse vous découvrez qu'elle est restée inconsciente 5 min environ après l'incident. L'enfant est en bon état général. Le status montre plusieurs égratignures sur les extrémités et plaie temporale gauche. Anisocorie légère (D 2mm, G 4mm). Reste du status neurologique dans la norme. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Blessure de la fissure orbitale supérieure
- b) Blessure directe de l'oeil
- c) Hématome sous-dural
- d) Hématome épidural
- e) Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique

57. Femme de 75 ans, présente un AVC avec hémisyndrome droit depuis 1h sur FA préexistante. Au CT pas de saignement. A l'angio-CT, occlusion de l'ACM gauche. Quelle est la prochaine mesure ?

- a) Lyse iv
- b) ASS 500mg
- c) Héparine non-fractionnée
- d) Inhibiteur GP-IIb/III et O2
- e) Craniotomie

58. Femme de 69 ans consulte à votre cabinet de gynécologie pour un saignement vaginal d'apparition nouvelle. Pas d'hormonothérapie. A l'US vous constatez un endomètre anormalement épais. Une biopsie est alors effectuée (voir superbe image noir-blanc). Quel est votre diagnostic ?

- a) Hyperplasie glandulaire de l'endothélium
- b) Simple atypie
- c) Endométriose
- d) Adénocarcinome endométrioïde
- e) Polype du corps

59. Comment peut-on différencier une amyloïdose primaire d'une amyloïdose secondaire ?

- a) Microscopie électronique
- b) Immunohistochimie
- c) Rouge congo
- d) Lumière polarisée
- e) Microscopie champ sombre

60. Jeune de 14 ans, 178cm, 77kg. Présente depuis 3 mois des douleurs au genou droit qui sont apparues après un effort physique et sont devenues plus fortes par la suite. Au status le genou est sp, bonne mobilisation, pas d'épanchement au niveau de l'articulation, pas de tuméfaction des parties molles, lig croisés et ménisques sp. Quel diagnostic ?

- a) Fissure du ménisque médial droit
- b) Rupture lig croisé postérieur droit
- c) Epiphysiolyse de la tête fémorale droite
- d) Ostéochondrose disséquante à droite
- e) Luxation de la patella

61) Une patiente de 81 ans chute dans les escaliers. Elle n'arrive plus à se relever. Une voisine la retrouve et appelle le médecin de garde qui la transfère à l'hôpital. Les signes vitaux

dans l'ambulance sont TA 110/76, FC 84, SpO2 96%. A l'hôpital elle présente des douleurs à la hanche droite. La jambe droite est plus courte que la gauche et est en rotation externe. Quel est le diagnostic probable ?

- a) Fracture de la diaphyse de fémur
- b) fracture du col du fémur
- c) Fracture de la cheville
- d) Fracture per trochantérienne

62) Un jeune de 17 ans diagnostiqué d'une appendicite doit être opéré. Le patient est afebrile, normocarde, normotendu, conscient et le statut neurologique et sp. Il est agressif, mais autrement psychologiquement rien d'inhabituel. Vous devez lui faire signer le consentement opératoire. Qu'est ce qui correspond au patient : (*chaud à traduire désolé*)

- a) il est majeur (mündig)
- b) il a sa capacité de discernement
- c) il n'a pas sa capacité de discernement
- d) il a sa capacité d'agir (handlungsfähig)
- e) il est sain d'esprit (zurechnungsfähig)

63) Vous êtes médecin généraliste dans un EMS, un patient de 71 ans avec un carcinome du colon avancé présente de symptômes d'ileus avec nausée et vomissement fécaloïde. Il est faible, alité, ne mange pas et ne boit pas. Quel est la suite de la prise en charge ?

- a) hospitalisation pour évaluation d'une prise en charge opératoire
- b) gastroscopie et éventuellement stent
- c) hydratation iv, sonde gastrique et antiémétique
- d) Somatostatine et antiémétique
- e) lavement gastrique et procinétique

64) Un enfant de 5 ans est amené en ambulance suite à une courte perte de connaissance lors d'une journée sportive. IL n'est autrement pas malade et n'a pas de plainte. La mère explique qu'il n'a rien mangé à déjeuner et qu'il est de manière générale très émotionnel. Quel est le diagnostic probable ?

- a) hypoglycémie
- b) Hyperventilation
- c) Coup de chaleur
- d) syncope vasovagale
- e) syncope orthostatique

65) Quel propriété de médicaments augment les effets indésirables et les effets secondaire ?

- a) effet thérapeutique large
- b) biodisponibilité faible
- c) clairance hépatique faible
- d) augmentation de l'absorption gastrique
- e) diminution de l'effet de premier passage

66) Sensibilité et spécificité

	Positif	Négatif	Total
Malade	950	50	1000
Sain	10	990	1000

Qu'est ce qui est exact ?

- a) Sensibilité 95%

- b) Spécificité 95%
- c) Sensibilité 99%
- d) Sensibilité 1%
- e) Spécificité 1%

67) Un patient présente un infarctus du myocarde et un choc cardiogénique. On a déjà installé le cathéter d'angioplastie pour la stabilisation hémodynamique. Dans ses directives anticipées il exige aucun acharnement thérapeutique si le pronostic est fatal. La famille dit qu'elle n'était pas au courant et qu'ils sont choqués par ces directives. La fille du patient est enceinte et elle est sûre que son père aimerait voir son futur petit fils. Que faire ?

- a) arrêter la thérapie et accepter les directives du patient
- b) poursuivre la thérapie et respecter les souhaits de la famille
- c) Evaluation par le corps médical des moyens à mettre à disposition et de l'outcome clinique
- c) demander l'avis du généraliste
- e) demander l'avis du comité éthique de l'hôpital

68) Un patient alcoolique présente une angine. Le généraliste le traite avec de la pénicilline. Le patient arrête la thérapie après 3 jours car il se sent mieux. Péjoration de l'état avec une voix étouffée, trismus, douleur et inflammation à gauche et de la fièvre. Voile du palais pas visible à cause du trismus. Diagnostique :

- a) Abscess du plancher buccal
- b) Lymphome aigue
- c) Abscess pérityonsillaire
- d) Métastase de la base de la langue
- e) épiglotte

69) Une patiente de 18 ans consomme 150 comprimés de 500mg d'aspirine pour se suicider. 2 heures après elle vomit deux fois. 6 heures après elle arrive aux urgences. Elle est afébrile, bon état général, SV sp sauf une ventilation profonde. Que faire ?

- a) Hémodialyse
- b) lavage gastrique
- c) Charbon actif
- d) Substitution thrombocyte
- e) Gastroskopie pour enlever les comprimés

71) Vous participez à un Tumorboard de sénologie, durant lequel le cas suivant est discuté : une patiente de 51 ans a bénéficié d'une tumorectomie (résection segmentaire) et d'une biopsie du ganglion sentinelle axillaire, il y a deux semaines. Les résultats de la pathologie et le statut des récepteurs hormonaux sont présentés. Lequel des paramètres suivants n'influence pas le choix de la thérapie postopératoire ?

- a) Taille tumorale
- b) Marge de résection
- c) Degré de différenciation
- d) Type histologique
- e) Statut des récepteurs hormonaux

72) Les 5 hôpitaux universitaires coordonnent l'intégration dans la cohorte nationale de patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Une analyse a démontré une haute prévalence de patients avec des antécédents de complications sévères de la maladie de Crohn. Quel biais a conduit à ce résultat ?



- a) Biais de confusion
- b) Biais de classement
- c) Biais de publication
- d) Biais de rappel
- e) Biais de sélection

73) Patient de 65 ans avec douleurs abdominales basses, douleur diffuse à la palpation à gauche, leucocytes 16G/l, subfébrile. Le CT met en évidence une diverticulite du colon sigmoïde avec infiltration de la graisse, pas d'air libre ni de liquide libre dans l'abdomen. Thérapie ?



- a) Antibiotique
- b) Colostomie de dérivation et drainage
- c) Résection et colostomie
- d) Résection du sigmoïde
- e) Hartmann (protosigmoïdectomie)

74) Une patiente de 85 ans est amenée aux urgences par la police, après avoir été retrouvée désorientée dans la rue. La patiente ne parle pas et ne semble pas comprendre ce qu'on lui dit (regarde le plafond quand on lui demande de regarder à droite ou à gauche). L'examen clinique ne montre pas d'anomalies, pas de méningisme, pas de latéralisation, abdomen souple et indolore, pas de douleur des loges rénales, l'examen neurologique est dans la norme, pas de fièvre (36.8°C). Rx thoracique sans particularité. Hypertension à 180/100mmHg. Laboratoire : leucocytose avec déviation gauche, CRP 300, légère hyperglycémie, K⁺ et Na⁺ dans les limites supérieures de la norme (Na⁺ légèrement en dessus), augmentation marquée de la créatinine (125), urée augmenté, nitrites ++ au stix urinaire. Vous téléphonez à son mari qui vous fait remarquer que sa femme ne présente normalement pas d'état confusionnel ni de démence.



Quelle est la cause de la situation actuelle ?

- a) Lésion cérébrale sur hypertension
- b) Etat confusionnel aigu sur infection urinaire
- c) Episode dépressif majeur avec mutisme réactif
- d) Infection cérébrale (encéphalite, méningite)
- e) Insuffisance rénale avec encéphalopathie urémique

75) Une femme de 60 ans se présente à votre cabinet en raison de douleur importante de l'œil droit d'apparition brutale. Elle explique qu'elle présente une hypermétropie depuis l'âge de 40 ans pour laquelle elle porte des lunettes. Depuis que les douleurs ont commencé, elle a l'impression de moins bien voir de l'œil droit. Votre examen ophtalmologique montre ceci : l'œil droit est érythémateux. Pas de strabisme, l'examen à la fluorescéine, la mobilité oculaire et le réflexe corné sont normaux. Acuité visuelle gauche 0.8, droite 0.1. Du côté droit il y a des opacités cornéennes. La pression intraoculaire gauche 21mmHg droite 22mmHg*. Le globe oculaire droit semble plus dur à la palpation que le gauche. Quel diagnostic est le plus probable ?



- a) Uvéite
- b) Glaucome aigu
- c) Conjonctivite
- d) Décollement de rétine
- e) Corps étranger

* il y a sûrement une erreur de transcription car un glaucome n'est pas douloureux si la pression intraoculaire n'est pas élevée !

76) A quel degré les lignes directrices de l'Académie Suisse des Sciences Médicales sont-elles contraignantes ?

- a) Légalement contraignantes
- b) Légalement contraignantes mais seulement pour les membres du FMH
- c) Moralement contraignantes
- d) Pas contraignantes
- e) Aucune des réponses ci-dessus

77) Dans votre service, il y a un patient de 78 ans à qui on vient de diagnostiquer un carcinome de la prostate. Vous lui expliquez qu'avec une opération ou radiothérapie il a de bonnes chances de guérison. Malgré tout il refuse toute forme de traitement, car il a eu une belle vie et est prêt à mourir. Quel principe éthique devez-vous observer ?

- a) Autonomie
- b) Bienfaisance
- c) Non-malfaisance
- d) Bienfaisance
- e) Justice

78) Une patiente asthmatique et diabétique de 65 ans s'est égratignée la cuisse avec une épine de rose en jardinant. 3 jours plus tard la cuisse est rouge et enflée. La patiente se présente chez le généraliste qui l'envoie aux urgences. Aux urgences, elle reçoit une antibiothérapie iv à la pénicilline. 30h plus tard, la jambe est de couleur livide et à un endroit une vésicule de 5cm s'est formée. Les douleurs augmentent et la rougeur s'étend sur le haut de la cuisse. Quelle est la prochaine étape ?

- a) IRM
- b) Hémoculture
- c) CT
- d) Frottis de plaie
- e) Opération

79) Lors d'un accident de voiture, un homme de 34 ans a été éjecté de la voiture et est amené inconscient et intubé aux urgences, GCS 5. Aucune blessure externe, hémodynamiquement stable. Quelle imagerie est indiquée ?

- a) CT crânien, Rx thoracique et de la colonne deux incidences
- b) CT crânien, US abdo, Rx des membres deux incidences
- c) Rx crânien deux incidences, Rx des membres
- d) CT thoracique et crânien
- e) Rx de la colonne cervicale, Rx thoracique deux incidences

80) Aux urgences, un patient de 55 ans avec une rupture de l'aorte et Hb à 8g/dl. C'est témoin de Jehovahs et il vous montre ses directives anticipées indiquant qu'il ne veut en aucun cas une transfusion sanguine. Il veut absolument être opéré car il ne veut pas mourir. Il existe une faible chance de le sauver avec une opération même sans transfusion sanguine. Quelle affirmation concernant l'opération

- a) Comme le patient n'est pas capable de discernement vous lui faites une transfusion si nécessaire
- b) Vous appelez un psychiatre
- c) Vous respectez ses volontés et ne faites pas de transfusion même en cas d'urgence

- d) Vous ne dites rien au patient mais lui donnez du sang si vous pensez que c'est nécessaire
- e) Vous n'opérez pas le patient

81. Une patiente de 34 ans s'est fait réséquer un mélanome malin de type nodulaire, Breslow 2.3mm, à la partie supérieure du bras. Par quelle méthode peut-on être certain que les plus petites micro-métastases seront aussi détectées ?



- (a) Résection du ganglion axillaire.
- (b) Scintigraphie du ganglion sentinelle
- (c) CT axillaire
- (d) IRM axillaire
- (e) Tomographie à émission de position

82. Vous êtes appelé par l'unité de soins palliatifs pour une patiente de 35 ans atteinte d'un carcinome mammaire avancé T4N3M1. La patiente a des métastases aux poumons et au foie et est actuellement fortement dyspnéique lui empêchant de parler. Que faites-vous pour soulager ses symptômes ?



- (a) Oxygène par sonde nasale et héparine i.v. (par suspicion d'une embolie pulmonaire)
- (b) Morphine
- (c) Morphine et BZD
- (d) Bêta-adrénérgique et anticholinergique (par suspicion d'une obstruction bronchique réversible)
- (e) Morphine et métoclopramide

83. Une femme de 80 ans s'est réveillée durant la nuit à cause d'un important saignement de nez. Lorsqu'elle se présente aux urgences, elle saigne depuis 3 heures et cela ne s'arrête pas. Elle est pâle et présente une baisse de l'état général. FC 105, TA 100/65. La patiente dit prendre du Marcoumar. Quelle action entreprenez-vous en premier ?



- (a) Appeler l'ORL pour faire une électrocoagulation
- (b) Donner de la Vit K
- (c) Déterminer l'hémoglobine
- (d) Mettre un accès veineux
- (e) Tenir (zuhalten) le nez et mettre du froid sur le cou

84. Vous êtes médecin dans un EMS et le personnel soignant vous informe qu'ils ont constaté chez une patiente de 80 ans une grosse tumeur dans la région génitale (image avec prolapsus de l'utérus). La patiente est assise la plupart du temps au fauteuil et ne se déplace presque plus. De plus, elle souffre de rétention urinaire. Quel est votre prochaine action ?



- (a) Cystoscopie
- (b) Biopsie tumorale
- (c) CT
- (d) Pose de pessaire et crème-oestrogènes
- (e) Hystérectomie totale

85. Une femme de 82 ans présente un jour après une intervention abdominale, une enflure douloureuse du genou et de la fièvre à 39 degrés. Quelle prochaine étape diagnostique va assurer votre suspicion diagnostic ?

- (a) Vitesse de sédimentation
- (b) Acide Urique dans le sérum
- (c) Ponction articulaire
- (d) CT du genou
- (e) IRM du genou

86. Un patient de 70 ans connu pour un DM type 2 arrive aux urgences avec suspicion d'AVC. Pour s'assurer du diagnostic vous voulez faire un CT injecté. De quelle valeur devez-vous auparavant vous assurer ?

- (a) Transaminases
- (b) Créatinine
- (c) Hb et Thrombocytes
- (d) L'exposition au rayonnement
- (e) HbA1C

87. Un fille de 8 ans vous est présentée suite à 2 semaines d'apathie, de subfébrilité et de malaise. Elle n'a pas pris de médicaments et n'a pas eu de contact avec son entourage. A l'examen clinique vous notez un ictère et une légère hépatomégalie. Vous redoutez une maladie hépatique lourde. Quelles valeurs de laboratoire démontrent un problème de synthèse hépatique ? (Dans les questions A mais ne serait-ce pas une K' ??)

- (a) ALAT 2000 U/L
- (b) γ -GT 800U/L
- (c) Thrombocytes 50 G/L
- (d) Quick 34%
- (e) Bilirubine 260 micromol/L

88. Vous êtes appelé par les soins intensifs de Néonatalogie où il y a un nouveau-né de 10 jours avec une lourde insuffisance cardiaque. L'enfant est déjà sous respiration et avec Spironolactone et Furosémide. L'analyse sanguine démontre les valeurs suivantes : pH : 7.25, pCO₂ : 25mmHg, pO₂ : 120mmHg, HCO₃ : 17mmol/L. Quelle est la probable raison de l'acidose ?

- (a) Acidose lactique
- (b) Perte de bic sur diurétiques
- (c) Insuffisance respiratoire
- (d) Acidocétose
- (e) Rétention d'acide sur spironolactone

89. Une héli thyroïdectomie est effectuée chez une patiente de 45 ans sur la base d'un goitre multi nodulaire. Sur la biopsie on découvre plus tard un carcinome thyroïdien papillaire T1a. Vous n'avez actuellement pas d'information sur des ganglions ou des métastases solides. Comment continuez-vous ?

- (a) Attendre

- (b) Thyroïdectomie radicale et substitution hormonale
- (c) Thyroïdectomie radicale, retrait des ganglions régionaux et thérapie par hormones thyroïdiennes suppressives.
- (d) Thyroïdectomie radicale suivie par une radiothérapie ablatrice et une substitution hormonale
- (e) Chimiothérapie en combinaison avec radiothérapie externe

90. Une patiente de 76 ans vient dans votre cabinet pour un contrôle. Il y a 6 mois, son mari est décédé de manière inattendue. Il y a 4 mois elle s'était présentée à votre cabinet avec une dépression importante et vous aviez débuter une thérapie par SSRI. Aujourd'hui elle vous dit que ça va de nouveau beaucoup mieux, qu'elle a plus d'énergie et qu'elle a retrouvé la joie de vivre.

Dans son dossier vous lisez que la patiente a déjà eu des épisodes dépressifs à 58, 70 et 74 ans. La thérapie médicamenteuse par SSRI a jusqu'à aujourd'hui toujours bien fonctionné. Comment continuez-vous avec le traitement ?

- (a) Vous stoppez complètement le médicament
- (b) Vous réduisez la dose de moitié
- (c) Vous donnez à la patiente un placebo à la place du SSRI
- (d) Vous continuez la thérapie à la même dose
- (e) Vous débutez une diminution du médicament

91. Un homme de 53 ans est admis par la « FFE » (??) dans votre clinique. Il y a quelques mois, le bureau de la sécurité sociale s'est rendu compte qu'il était venu plusieurs fois sans s'annoncer pour demander avec véhémence de grosses sommes d'argent. Dans de nombreuses lettres, il a expliqué avoir été capturé et torturé par les services secrets du Conseil fédéral et qu'il avait maintenant droit à un défraiement. Il se sent maltraité par l'état Suisse et c'est selon lui une conspiration venant de « tout en haut » qui est menée contre lui. Les demandes d'argent sont toujours plus agressives, jusqu'au jour où il a débarqué au bureau de la sécurité sociale avec un pistolet et a demandé son argent. Ses voisins le décrivent comme très en retrait et légèrement négligé vivant seul dans une maison et ne faisant confiance à personne. Avec ces infos que pensez-vous qu'il a comme trouble de la personnalité ?

- (a) Anankastique
- (b) Schizoïde
- (c) Paranoïde
- (d) Antisociale
- (e) Combinée

92. Une femme de 80 ans connue pour une HTA, vient aux urgences avec une importante douleur au dos. Le CT que vous avez demandé démontre une dissection aortique qui s'étend de l'a. subclavière gauche jusqu'au diaphragme. Aucune évacuation de liquide de contraste n'a pu être démontrée. La patiente est HD stable. Comment poursuivez-vous ?

- (a) Contrôle chez son MT
- (b) Abaisser la TA
- (c) Analgésie et passer la nuit aux SI.
- (d) CT de contrôle dans 6 jours
- (e) On file au bloc

EXAMEN HASHTAG 2 TYPE K' :

01. Un agriculteur de 68 ans a été retrouvé mort. Sa femme explique qu'il souffrait d'une maladie cardiaque. Quelles affirmations sont vraies ?



- (a) En se basant sur la couleur des lividités, on peut établir l'heure exacte du décès.
- (b) La rigidité musculaire aux 4 extrémités est un signe clair de décès.
- (c) Les lividités donnent une idée sur l'heure du décès.
- (d) „Die Wegdrückbarkeit der violett-roten Flecken an den abhängigen Körperpartien gibt Hinweise auf den Todeszeit.“ Désolé, impossible...

02. Jeune femme avec grossesse normale née à terme sans complication. Le nouveau-né a une adaptation normale (Apgar 9/10/10), les deux premières semaines après l'accouchement tout est normal. Maintenant ils trouvent au contrôle chez le pédiatre que même sous stimulation, sa fréquence cardiaque ne monte pas au-dessus de 68bpm. Quel examen est indiqué ?



- (a) ECG
- (b) US
- (c) Anticorps anti-lupus chez la mère
- (d) Exclure une hypothyroïdie chez l'enfant

03. Une Dame de 75 ans avec insuffisance rénale nécessite le remplacement de sa prothèse de hanche. Elle développe à 3 jours post-op un épisode de dyspnée aiguë, tachycardie et une douleur au thorax respiro-dépendante. La plaie de l'opération est sp. Les D-dimères sont à 2x la norme. Créatininémie 140micromol/L. Quel faire pour la suite ?



- (a) Analyse sanguine
- (b) Rx Thorax
- (c) CT avec produit de contraste
- (d) Scintigraphie ventilation-perfusion

04. (Traduction ???) Image avec défaut de substance entouré de Streif et rougeurs, pas Schmauch- / poudre disséminations pas Schmauchhöhle. Blessure latérale légèrement vers le sommet. Dans les mains de la personne décédée aucune particule n'a été retrouvée. Qu'est-ce que le médecin légiste peut en déduire?



- (a) Il s'agit d'une blessure par balle.
- (b) Le coup a été tiré à bout portant
- (c) Il est possible que la victime ne soit pas morte immédiatement
- (d) Il s'agit d'un suicide

EXAMEN HASHTAG 2 BONUS TYPE A :

01. Une patiente de 65 ans fait pour la première fois une syncope. A l'hôpital elle n'a pas de symptômes, anamnèse sp, ECG normal, test d'orthostatisme normal. Suite des investigations ?

- 
- (a) Tilt test
 - (b) EEG
 - (c) CT crâne
 - (d) ECG Holter, 24h de mesure de TA
 - (e) Rien

02. Patient de 50 ans connu pour un HIV, est amené par sa famille car depuis quelques mois il a des changements de personnalité avec un comportement agressif et un manque de tact. A l'hôpital il dérange les infirmières avec des remarques salaces. Où est le plus probablement localisé la lésion cérébrale ?

- 
- (a) Frontal
 - (b) Pariétal
 - (c) Cérébelleuse
 - (d) Temporal
 - (e) Ganglions de la base

03. Une femme de 68 ans qui consomme depuis des années 50g d'alcool par jour se présente avec un ictère, un abdomen distendu avec une douleur diffuse à l'hypochondre droit. Le labo montre : GGT élevés, ASAT/ALAT fortement élevés, MCV élevé, bili élevée. Quel examen complémentaire soutient le diagnostic présumé ?

- 
- (a) US abdo
 - (b) Biopsie hépatique transjugulaire
 - (c) IRM
 - (d) CT
 - (e) US des voies biliaires

04. A la consultation préopératoire d'un homme de 50 ans, une TA de 168/101 est mesurée. Suite des examens ?

- 
- (a) Reprendre la TA après 15min et 30 min
 - (b) Donner un IEC
 - (c) Repousser l'opération
 - (d) → pas d'autres propositions

05. un homme vient en ambulance pour une hémorragie sous-arachnoidienne. À l'entrée, GCS : 13. L'infirmière appelle après 2h, le patient n'est plus réveillable et le GCS est à 7. Mydriase unilatérale, cause la plus vraisemblable ?

- 
- hydrocéphalie occlusive parce que 4^{ème} ventricule est bouché
 - vasospasme cérébral
 - récurrence de saignement
 - convulsion

06. dame de 35 ans avec douleurs abdo basses de types crampes-tiraillement qui sont plus faciles à supporter quand a les hanches pliées. N'a pas besoin de spasmolytiques. Streptocoques au frottis vaginal. Diagnostic ?

- diverticulite
- appendicite
- abcès tubo-ovarien
- carcinome du colon
- GEU

07. femme de 30 ans avec des fortes céphalées. CT avec contraste avec signe du delta.

- tumeur intracrânienne
- kyste congénital
- thrombose du sinus veineux
- saignement

08. homme de 48 ans avec DM type II connu. Traité avec glitazone et metformine. Présente de la fièvre, de la toux et une pneumonie basale est diagnostiquée à l'aide d'une Rx du thorax. Il a nouvellement une forte soif et une polyurie. Quelle est la raison de la polyurie ?

- acidose métabolique
- hypocalcémie
- hyperglycémie
- glycosurie
- hypercalcémie

09. femme de 62 ans, BMI 37, ménopausée depuis 10 ans, a depuis 2 mois une dysménorrhée et une métrorragie, pas d'hormonothérapie. Col de l'utérus atrophié, US abdo pas faisable. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?

- CT bassin
- colonoscopie
- hysteroscopie avec curetage fractionné
- IRM
- attendre et contrôle dans 3 mois

10. femme de 35ans, G5 P3, 37 SA. 1h après la naissance d'un n-né de 4100gr, placenta entier, oxytocine prophylactique donnée (5IE). Perd maintenant 1500cc de sang, quelle est la suite ?

- commander un concentré érythrocytaire et... (on ne sait pas la suite de la réponse)
- donner methergin (pour contracter l'utérus)
- donner une 2^{ème} fois oxytocin 5IE
- considérer hystérectomie
- réviser vagin, col et utérus

11. un patient aux soins intensif développe des papules qui grattent sur le torse, le pénis et en interdigital. Deux autres patients développent aussi ça. Cause la plus vraisemblable ?

- virus coxsackie
- impetigo contagieux
- parvovirus B19
- Hépatite A
- gale

12. un homme de 67 ans avec une consommation régulière d'alcool, une hyperTA connue et un DM type II développe, 12h après son entrée élective pour une OP d'une hernie inguinale, une ataxie, une paralysie du regard et est désorienté. Quel médicament on prescrit ?

- vitamine A
- pyridoxine
- cobalamine
- thiamine

13. un enfant de 9 mois est amené aux urgences par ses parents car a de la fièvre et pleure depuis le matin. À l'examen on trouve une fontanelle bombante, on suspecte une hypertension intracrânienne et on demande à une ophtalmologue de faire un fond d'œil. La papille est normale mais il y a une hémorragie en flamèche sur la rétine. Diagnostic le plus probable ?

- toxoplasmose
- méningite bactérielle
- bébé secoué

16. Un nourrisson est retrouvé dans son lit inconscient par ses parents, bleu au visage avec des convulsions rythmiques sur tout le corps. Les parents expliquent que le nourrisson a été somnolent encore pendant 20 minutes, avant de revenir à la normale. Lors de l'examen, température à 38.9 °C, status général et neurologique sont sans particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Convulsion fébrile simple
- b. Convulsion fébrile compliquée
- c. Etat de mal
- d. Encéphalite virale

17. Une jeune patiente de 27 ans se plaint de diarrhée intermittente depuis 3 mois. Jamais de traces de sang. Elle ne présente pas de douleur et est afebrile. Il y a 6 mois, elle était à Bali. Quelle est la cause la plus probable ?

- a. Crohn
- b. Coeliakie
- c. Côlon irritable
- d. Giardia Lamblia

18. Une femme de 75 ans avec des vomissements, diarrhée et signes de déshydratation. Au labo (les valeurs sont mentionnées), on retrouve une hypokaliémie et une légère hyponatrémie. Que vous attendez-vous à retrouver dans le spot urinaire ?

Différentes valeurs de potassium et sodium, 3 fois proposition avec « osmolarité normale » et deux fois avec « osmolarité élevée »

19. Une femme G2P1 à 36 SA se présente aux urgences avec de violentes douleurs de l'abdomen inférieur et des saignements massifs. Son premier enfant est né par césarienne. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Placenta praevia
- b. Rupture de l'utérus

20. Une femme à 37 SA vient aux urgences pour des saignements vaginaux légers. Pas de douleur. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a. Décollement placentaire
- b. Placenta praevia

- c. Hémorragie Placentaire « randsinus » sinus marginal
- d. Rupture utérine
- e. Règle

21. Une femme au post-partum ? (im Wochenbett) a une température de 37.8°C. Le fundus est à 3doigts sous le nombril, l'épisiotomie est calme. Elle a des rhagades à la poitrine, les seins sont tendus mais indolores. Sticks urinaire montre Lc +, Protéine -, Nitrites -, Glucose +. Quelle est la cause de la température ?

- a. Endométrite
- b. Bronchite
- c. Infarctus myocarde
- d. Inflammation pelvis
- e. Lactogénèse (montée de lait)

22. Vous êtes appelé pour un garçon de 11 ans qui a eu une appendicectomie sur appendicite aiguë il y 3 jours. En post-op, il a reçu une analgésie par paracétamol et ibuprofène. La reprise alimentaire a recommencé sans problème le 1er jour post op. Maintenant, il a vomi une fois du sang et a eu des selles noires avec des traces de sang. Quelle est la cause des saignements ?

- a. Gastroentérite virale
- b. Hémorroïdes
- c. Ulcère duodénal
- d. Sy. Mallory-Weiss
- e. Varices oesophagiennes

23. Une femme G2P2 à la 12ème SA vous consulte car son garçon a eu la varicelle. Elle aimerait savoir ce qu'elle doit faire. Que lui conseillez-vous ?

- a. De rester tranquille et rentrer à la maison
- b. Sérologie en urgence
- c. Donner des Ig
- d. Conseiller une interruption de grossesse
- e. S'isoler de son premier enfant

24. Aux urgences, se présente un patient après un accident avec des fractures de la jambe, de multiples écorchures et des fractures en série des côtes. Sa tension artérielle chute et il devient tachycarde. Il se plaint de dyspnée. Vous trouvez une turgescence des veines du cou (gestaute Halsvenen). Que faites-vous ?

- a. Donner O2 et surveillance de saturation
- b. Catécholamines et surveillance de pression artérielle
- c. Drain thoracique
- d. CT du corps entier

25. Un patient de 40 ans transplanté rénal présente des symptômes de pneumonie. Histologie avec la coloration de Grocott (grocottfärbung ??) montre des spores d'hyphae. (lien pour aller voir l'image). Quelle est la cause ?

- a. Aspergillose
- b. Pneumonie à pneumocystis jirovecii
- c. Pneumocoque
- d. Mycoplasme
- e. CMV



26. Un homme de 23 ans, dysurie, écoulement purulent urétral. Quelle est la prochaine étape diagnostic ?

- a. PCR urinaire Neisseria gonorrhée
- b. PCR urinaire N. gonorrhée et chlamydia trachomatis



27. Une femme de 30 ans prend depuis 4 jours 20mg de paroxétine (Deroxat) et vient vous voir en urgence. La patiente est sinon en bonne santé. Elle se plaint d'un état anxieux, tremblements, vertiges et nausées.

- a. Virage maniaque
- b. Syndrome sérotoninergique
- c. Akathisie



28. Un couple de parents vient avec son nouveau-né de 6 semaines, lequel dort et est apathique et depuis 4h a des vomissements bilieux alors qu'il était en parfaite santé. Cliniquement, le nouveau-né est pâle, un état général diminué, froid en périphérie, tachycarde et abdomen souple et pas distendu.

Que peut être la cause des vomissements ?

- a. Gastroentérite
- b. Volvulus
- c. Sténose du pylore
- d. Kyste du cholédoque
- e. M. Hirschprung